세일즈혁신 교안

설계사 교육 · 입원적정성 편

입원인 줄 알았는데 통원이었다

입원적정성, 입원이 통원이 되는 시대의 보장 설계

메리츠화재 세일즈혁신 2026. 10. 23 (금)

왜 논란인가 · 고객이 손해 보는 사례 · 의료·건보·실손의 배경 · 실손 재매입 · 당사 특약 점검과 트렌드

병원 침대에 누웠다고 입원이 아니다

6h

병원에 머문 시간이 짧으면 입원이 아니라 통원으로 본 분쟁 사례의 기준선. 자세한 내용은 2부

한 장 요약. 입원은 줄고 심사는 는다, 그래서 보장은 「입원」이 아니라 「치료 행위」에 걸어야 한다

주: 수치는 출처를 붙였고, 출처가 없는 값은 「추정」으로 표시했다. 특약 이름은 당사 약관 명칭 그대로다

01 · 1부

왜 논란인가

입원의 뜻은 약관이 정하고, 판정은 심평원과 보험사가 한다. 고객은 침대에 누운 사실만 기억한다. 세 시선이 다르니 분쟁이 생긴다

02 · 2부

고객이 손해 보는 사례

백내장 다초점, 당일 입퇴원, 도수치료 입원, 하이푸·맘모톰, 요양·한방병원, 응급실 체류. 여섯 사례 모두 「입원」이 「통원」으로 바뀌며 한도가 줄었다

03 · 3부·4부

네 가지 배경

의료기술은 재원일수를 줄이고, 건보 재정은 입원을 억제하고, 실손 손해율은 심사를 늘리고, 제도는 비급여를 관리한다. 네 힘이 한 방향이다

04 · 5부·6부

당사 특약과 트렌드

입원이 지급 조건인 특약(입원일당 계열)은 설명 의무가 커지고, 치료 행위가 조건인 특약(수술비·치료비·통원일당·통합치료비)은 가치가 오른다

설계 한 줄 정리: 「며칠 입원했나」가 아니라 「무슨 치료를 받았나」로 보장을 설명하고 설계한다

여섯 부분, 질문 하나

「고객이 입원했다고 믿는 순간, 보험은 무엇을 보고 있는가」

01 **입원적정성이란**
약관의 입원 정의 · 심사 제도 · 세 시선

02 **고객이 손해 보는 사례**
여섯 장면, 입원이 통원이 되는 순간

03 **네 가지 배경**
의료기술 · 건보 재정 · 실손 손해율 · 제도

04 **실손 재매입과 5세대**
1~2세대 재매입 · 5세대 구조 · 고객 선택

05 **당사 특약 점검**
논란 소지 특약 · 가치가 오르는 특약 · 잠재력 순위

06 **현장 실천**
상담 화법 · 입원 전 안내 5가지 · 정리

진행 90분 기준. 각 부 끝의 「한 줄 정리」만 모아도 교육의 뼈대가 된다

PART 01

입원적정성이란

병원 침대 위의 입원과 약관이 정한 입원은 다르다. 그 틈에서 논란이 생긴다

01 입원적정성이란

02 고객이 손해 보는 사례

03 네 가지 배경

04 실손 재매입과 5세대

05 당사 특약 점검

06 현장 실천

약관의 「입원」은 네 가지 요건을 모두 채워야 한다. 하나라도 빠지면 침대에 누웠어도 입원이 아니다

① **의사가 치료가 필요하다고 인정**

의사·치과의사·한의사의 판단이 먼저다. 환자가 원해서 하는 입원은 요건이 아니다

② **자택 등에서 치료가 곤란**

집에서 할 수 있는 치료(경구약·단순 관찰)는 입원의 이유가 되지 못한다

③ **의료기관에 입실**

의료법상 병원·의원. 요양병원·정신병원·한방병원을 빼는 특약이 많다(아래 원문)

④ **의사의 관리 하에 치료에 전념**

입실 뒤 외출·외박, 관찰·처치 기록이 없는 체류는 「전념」으로 보지 않는다

당사 약관 원문 · 질병입원일당 계열

「입원」이라 함은 의사가 치료가 필요하다고 인정한 경우로서, 자택 등에서의 치료가 곤란하여 의료법 제3조 제2항에서 정한 국내의 병원, 의원(단, 국내의 요양병원, 정신병원, 한방병원은 제외됩니다)에 입실하여 의사의 관리 하에 치료에 전념하는 것을 말합니다.

「6시간」은 약관 본문이 아니라 복지부 고시와 판례에서 온 보조 기준이다. 약관이 묻는 것은 「필요·곤란·입실·전념」이다

출처: 당사 특약 약관(tool_body.js 수록 원문, 요양·정신·한방병원 제외 문구는 특약별로 다름) · 손해보험협회 실손 안내(계속 6시간 이상 체류) · 대법원 2006.1.12 선고 2004도6557(체류시간만으로 판단 불가, 증상·진단·치료 내용 종합). 실손 표준약관 원문의 6시간 문구 유무는 미확인

같은 하루 병원에 있어도 보험은 네 가지로 나눈다. 고객이 아는 것은 「입원」 하나뿐이라 셋은 설명이 필요하다

구분	무엇인가	보험에서 보는 눈	당사 특약 예(약관 명칭)
입원	의사가 필요 인정 + 자택 치료 곤란 + 입실 + 관리 하 전념	입원일당·입원의료비의 지급 전제. 체류 시간·관찰 기록·개별 필요성을 본다	질병입원일당(1일이상) · 상급종합병원 질병입원일당 · 간병인사용 질병입원일당(plus)
낮병동 입원	입원실 없이 6시간 이상 관찰·치료 후 당일 귀가(복지부 고시 입원료 산정)	실손은 대개 입원으로 본다. 일반 입원일당은 특약에 따라 지급 대상이 아닐 수 있다	종합병원암직접치료낮병동입원일당(급여, 1일1회한, 연간20일한도)
응급실 체류	응급실에서 처치·관찰 뒤 귀가. 병실 배정 없음	입원이 아니다. 응급실 내원 자체를 보장하는 특약이 따로 있다	응급실내원비(응급) · 응급실내원비(1-3등급)
통원	입원하지 않고 의사 관리 하에 치료(약관 정의)	실손은 통원 한도(세대별 20~30만원)로 지급. 정액 특약은 치료 행위 자체를 본다	뇌혈관질환통원일당(연간30회한) · 암직접치료통원일당(상급종합병원) · 수술비 · 치료비 계열

입원일당은 「입원」 한 칸만 본다. 통원일당·응급실내원비·수술비·치료비는 나머지 세 칸을 메운다

출처: 당사 약관 「입원」·「통원」·「낮병동 입원(급여)」·「응급실」 정의(tool_body.js) · 심평원 낮병동 입원료 안내(관찰에만 최소 6시간) · 금감원 2025.3.10 유의사항(통원 한도 20~30만원). 응급실·낮병동의 통원 판정 판례는 공신력 있는 자료가 없어 약관 구조로만 설명한다

「입원적정성」은 두 절차에서 쓰인다. 수사기관이 의뢰하는 심평원 심사와, 보험사가 지급을 심사하며 하는 의료자문. 현장 분쟁의 대부분은 뒤쪽이다

형사 · 보험사기방지특별법 제7조

심평원 입원적정성 심사

수사기관 의뢰 → 자문회의 → 공공심사위 → 수사기관 통보

허위·과다 입원 의심 건을 수사기관만 의뢰할 수 있다. 진료기록·간호기록으로 입원 필요성과 기간을 판단한다(심평원 공고 2024-193호, 2024.8.14 시행). 연평균 의뢰 약 1만 5천 건, 미결은 2015년 3,300건에서 2020년 8월 35,905건으로 늘고 평균 처리일수는 98일에서 761일이 됐다. 대법원(2018)은 이 회신의 형사 증거능력을 부정했다. 심평원 판단이 곧 유죄는 아니다.

민사 · 약관 해석과 지급심사

보험사 의료자문 · 지급심사

청구 → 서류 심사 → 의료자문 → 입원 → 통원 판정

고객이 겪는 「입원이 통원이 됐다」는 거의 여기서 일어난다. 2025년 상반기 손보 청구 4,581만 건 중 의료자문 22,435건, 그중 2,347건(10.5%) 부지급. 손보 실손 분쟁은 2024년 7,264건이며 도수치료·백내장·무릎주사 세 항목이 53%다. 2026.9.14 금감원은 「자체 판단 가능한 사안까지 과도한 자문으로 지급이 지연된다」며 주치의 소견 검토를 먼저 하라고 요구했다.

둘을 섞어 말하면 고객에게는 「보험사기 의심」으로 들린다. 통원 판정은 약관 해석, 심평원 심사는 수사의 문제다

출처: 데일리메디 2024.8(심평원 공고) · 법무법인 지평 뉴스레터 2024.8 · 메디칼타임즈(2020 국감, 백종헌 의원실) · 청년의사 · 허영 의원실(금감원 자료, 2025.10) · 금감원 제2차 금융소비자보호 토론회 2025.11.18(이투데이) · 한국일보 2026.9.14. 전국 「입원 부적정」 판정 비율은 공개 통계가 없다

논란의 뿌리는 세 시선이 다르다는 것. 고객은 침대를, 병원은 수가를, 보험사는 약관을 본다

고객

「침대에 누워 하루 잤으니 입원이다」

입원 여부를 자기가 정했다고 믿는다. 통원 판정을 받으면 보험사가 약속을 어겼다고 느낀다. 2025년 손보 민원 48,281건의 52.8%가 보험금 산정·지급이다

병원

「환자 안전과 수가를 보면 입원이 낫다」

백내장·하이푸·정맥류·줄기세포 주사에서 환자별 상태 구분 없이 입원을 일괄 처방한 사례가 판결에 등장한다. 병상 OECD 3배인 구조가 입원을 쉽게 만든다

보험사 · 법원

「약관의 입원 요건을 채웠는가」

체류 시간, 관찰·처치 기록, 같은 날 통원으로 가능했는가를 본다. 대법원 2025.1.23(백내장)과 2026.6.11(하지정맥류)이 기준을 굳혔다

기준이 바뀌면 보험사는 2개 이상 채널로 안내하고 최소 3영업일 뒤 적용해야 한다(금감원 행정지도, 2026.6.22 시행). 2022년 백내장 판결 뒤 일괄 기준 변경으로 생긴 혼란이 계기였다

세 시선을 한 자리에 놓고 설명하는 사람이 설계사다. 「입원하면 나온다」가 아니라 「이런 입원이면 나온다」로 말한다

출처: 금감원 「2025년 금융민원 동향」 2026.4.21(쿠키뉴스) · 데일리메디 2026(한방병원 줄기세포 주사 판결) · 대법원 2024다305643(2025.1.23) · 대법원 2026다202566(2026.6.11) · 머니투데이 2026.6.21(행정지도) · 보건복지부 OECD 보건통계 2026 분석

법원과 보험사가 「통원」이라 말할 때 보는 여섯 가지 신호. 고객의 입원 전에 이 여섯을 미리 확인하면 분쟁의 절반은 사라진다

6시간 미만 체류

수술 준비부터 종료까지 2시간, 그 뒤 처치 없음(백내장 2022). 다만 6시간은 절대 기준이 아니다(2004도6557, 2026.5 항소심)

관찰·처치 기록 없음

진료기록에 입원 뒤 관찰·처치·부작용 기록이 없으면 「실질적 입원」이 아니다(대법원 2025.1.23, 원고 137명 패소)

같은 날 통원으로 가능

양다리 정맥폐쇄술을 하루씩 나눠 이틀 입원. 「같은 날 통원 수술 가능, 마취 두 번 할 사정 없음」(대법원 2026.6.11)

환자별 구분 없는 일괄 입원

한방병원 줄기세포 주사, 원고 9명 중 7명 기각. 병원이 환자 상태 구분 없이 입원을 일괄 처방

치료 필요성과 입원 적정성은 별개

하이푸 시술은 필요했지만 입원은 아니었다. 통원의료비 7만 5천원만 인정, 입원비 전부 기각

반대로, 합병증이 있으면 입원

출혈로 도뇨관을 당일 제거 못 한 환자, 약 6시간 체류 → 입원 인정, 미지급 402만원 지급 판결(2026.5)

여섯 신호 중 다섯은 「기록」의 문제다. 입원 전에 「왜 입원이 필요한지」를 의사에게 묻게 하면 기록이 남는다

출처: 서울고법 2021나2013354(2022.1.20, 대법원 2022.6.16 확정) · 대법원 2024다305643(2025.1.23, 금감원 2025.3.10 유의사항) · 대법원 2026다202566(2026.6.11, 연합 2026.7.23) · 데일리메디 2026(한방병원 줄기세포) · 메디컬투데이 2026.5.15(하이푸) · 연합·의협신문 2026.5.12(402만원 판결, 수술명 미보도)

PART 02

입원이 통원이 되는 순간

여섯 장면. 고객은 모두 「입원했다」고 믿었고, 결과는 통원 한도이거나 0원이었다

01 입원적정성이란

02 고객이 손해 보는 사례

03 네 가지 배경

04 실손 재매입과 5세대

05 당사 특약 점검

06 현장 실천

사례 1. 백내장 다초점렌즈 수술, 「입원해서 받았다」고 믿은 수백 명이 통원 한도만 받았다

고객의 생각

「수술하고 입원실에서 쉬다 왔어요. 수술비 1,000만원 중 실손으로 800~900만원은 나오겠지요」

판정

통원. 수술 준비부터 종료까지 약 2시간, 그 뒤 관찰·처치 없음. 실손 통원 한도만 지급

서울고법 2022.1.20 선고(대법원 2022.6.16 확정). 2025.1.23 대법원은 원고 137~141명·보험사 11곳 사건에서 「6시간 미만이거나 관찰·처치·부작용 기록이 없으면 실질적 입원이 아니다」로 원고 패소. 「약관에 체류시간이 없어 설명의무 위반」 주장도 기각

고객이 본 불이익

800만원 → 20~30만원

금감원 유의사항(2025.3.10): 수술비 1,000만원 기준, 입원 인정 시 800~900만원, 불인정 시 통원 한도 20~30만원

설계사 포인트

백내장은 OECD 평균 95%가 당일수술이다. 다초점렌즈 자체는 보상 대상이니 「입원」을 약속하지 말고 「수술 정액」으로 설명한다. 당사 130·131대질병수술비[백내장], 안과질환수술비는 입원 여부를 묻지 않는다

출처: 서울고법 2021나2013354·2013361 · 김앤장 2022.6 · 보험연구원 판례검토 · 대법원 2024다305643(2025.1.23) · 금감원 보도자료 2025.3.10(뉴시스·리걸타임즈) · 서울중앙지법 2024나44725(2025.3.19)

사례 2. 하지정맥류, 양다리를 하루씩 나눠 이틀 입원. 대법원은 「같은 날 통원으로 가능했다」고 봤고 당사도 9월부터 심사를 조였다

고객의 생각

「양쪽 다리를 다 해야 해서 이틀 입원했어요. 병원이 그렇게 잡아 줬고요」

판정

형식적 입원. 같은 날 통원 수술 가능, 마취를 두 번 할 사정 없음. 실손 입원의료비 지급 불가

대법원 2026.6.11 선고 2026다202566. 2023.3 이틀 입원해 양다리 정맥폐쇄술을 하루씩 받은 사건. 판결 뒤 삼성화재·메리츠화재 등이 사전안내문을 보내고 2026.9.9 시술분부터 입원 필요성 심사를 강화했다. 학회는 「특정 환자의 형식적 입원을 부정한 것, 확대해석 말라」

고객이 본 불이익

입원 2일 → 0원

입원의료비 전액 부지급. 입원일당 특약이 있었다면 그 역시 「입원」 요건 미충족

설계사 포인트

당사가 직접 안내문을 보낸 사안이다. 정맥류 고객에게는 「입원 2일」이 아니라 「시술 자체」를 보장하는 특약(질병 특정 비급여·신의료기술치료비 1종 「근골 및 하지정맥류질환」, 수술비 계열)으로 설명한다

출처: 대법원 2026다202566(연합 2026.7.23 보도) · 쿠키뉴스 2026.9.14(보험사 사전안내·9.9 심사 강화) · 메디팜헬스(대한정맥통증학회 입장)

사례 3. 자궁근종 하이푸, 「치료는 필요했지만 입원은 아니었다」. 법원은 치료 필요성과 입원 적정성을 따로 본다

고객의 생각

「시술 뒤 6시간 넘게 병원에 있었으니 입원이지요. 실손으로 입원비 받을 수 있지요?」

판정

통원. 원고 6명 중 1명의 질병통원의료비 7만 5천원만 인정, 입원비 전부 기각

서울중앙지법 1심(항소 없이 확정, 메디컬투데이 2026.5.15). 「6시간 체류만으로는 부족하다」. 별건 부산지법 항소심도 시술 필요성은 인정하되 입원의료비 요건은 충족하지 않는다고 판단

고객이 본 불이익

입원비 0원 · 통원 7.5만원

입원비 수백만원 기대 → 통원의료비 7만 5천원. 나머지는 전액 본인 부담

설계사 포인트

하이푸·맘모톰·갑상선 고주파는 통원화된 대표 시술이다. 당사 「특정질환3대치료비」(자궁근종 고강도초음파집속술 · 유방병변 진공보조장치이용절제 · 갑상선질환 고주파열치료, 최초 1회)는 입원과 무관하게 시술 자체를 본다

출처: 메디컬투데이 2026.5.15 · 의협신문(하이푸 판결) · 팜뉴스(부산지법 항소심). 1심 선고일은 보도에 없어 미확인

사례 4. 한방병원 줄기세포 주사, 9명이 같은 입원을 했는데 2명만 입원이었다. 「환자별 구분 없는 일괄 입원」은 입원이 아니다

고객의 생각

「병원에서 다들 입원해서 맞는다고 해서 입원했어요. 옆 침대 사람도 받았대요」

판정

7명 기각. 병원이 환자별 상태 구분 없이 입원을 일괄 처방. 2명만 개별 사정이 인정

서울중앙지법(2024년 시술분, 데일리메디 2026 보도). 무릎주사도 같은 논리다. 6시간 이상 체류했어도 개별 상태·합병증 위험이 의학적으로 확인되지 않으면 입원이 아니다(팜뉴스)

고객이 본 불이익

9명 중 7명 0원

같은 병원, 같은 처방인데 결과가 갈린다. 「옆 사람은 받았다」가 근거가 되지 못한다

설계사 포인트

당사 입원일당 특약 다수는 약관 정의에서 요양병원·정신병원·한방병원을 뺀다. 「한방병원 입원」은 실손 판정 이전에 특약 정의에서 먼저 걸린다. 가입 때 이 한 줄을 읽어 준다

출처: 데일리메디 2026(서울중앙지법, 선고일 미보도) · 팜뉴스(무릎주사). 다수 당사 입원일당 특약은 한방병원 입원을 정의에서 제외한다(tool_body.js 원문)

사례 5. 「숙박형」 요양병원 장기입원, 금감원이 꼽은 실손 허위청구 4대 유형. 고객은 간병을 받았을 뿐인데 수사 대상이 된다

고객의 생각

「요양병원에서 몇 달 지내며 치료받았어요. 입원일당이랑 실손 다 청구해야지요」

판정

허위 장기입원 유형. 금감원 2025.9.8 안내 사례에서 141명 검거. 입원 필요성 없는 「숙박」으로 판단

금감원 「실손 허위청구 4대 유형」: 진료비 쪼개기, 미용시술 둔갑, 허위처방 끼워넣기, 숙박형 요양병원 허위 장기입원. 2024년 실손·장기보험 허위·과다청구 2,337억원, 19,401명. 2026년 상반기 보험사기 6,199억 중 진단서 위변조·입원수술비 과다청구 1,473억

고객이 본 불이익

보험금 환수 + 수사

보험금 환수와 형사 절차. 심평원 입원적정성 심사로 넘어가면 평균 처리 2년 가까이 걸린다

설계사 포인트

당사 입원일당 특약은 대부분 「요양병원 제외」, 요양병원형은 별도 특약(간병인사용 질병입원일당(요양병원) 등)으로만 설계된다. 장기 입원이 필요한 고객에게는 「181일이상」 특약과 간병인지원 특약을 설명하고, 요양병원 여부를 먼저 묻는다

출처: 아시아투데이 2025.9.8(금감원 4대 유형) · 이지경제(2024 허위청구 통계) · 한국보험신문 2026(상반기 보험사기) · 메디칼타임즈(심평원 처리일수 761일, 2020 국감)

사례 6. 반대로 입원이 인정된 경우. 출혈로 도뇨관을 빼지 못한 약 6시간, 법원은 「6시간은 절대 기준이 아니다」라며 402만원을 지급하라 했다

고객의 생각

「수술 뒤 피가 나서 소변줄을 못 뺐어요. 그날 집에 못 가고 병원에 있었는데 보험사가 통원이래요」

판정

입원 인정. 합병증으로 당일 퇴원이 어려웠고 의사 관리 아래 처치가 이어졌다. 미지급 402만원 지급

서울중앙지법 민사합의부 항소심(2026.5 보도). 보험사는 복지부 고시 6시간 기준으로 통원을 주장했으나 배척. 「6시간 요건은 절대 기준이 아니다」. 수술명은 보도에 없다

고객이 본 불이익

통원 판정 → 402만원

처음 통원 판정을 받고 소송까지 가서야 받았다. 기록이 있었기에 이긴 사건

설계사 포인트

입원이 맞다면 이기는 근거는 「기록」이다. 퇴원이 늦어진 이유(합병증·처치)가 진료기록에 남도록 고객이 의사에게 말하게 한다. 6부 「입원 전 안내 5가지」의 셋째가 이것이다

출처: 연합뉴스(네이트) 2026.5.12 · 의협신문 2026. 수술명·사건번호는 보도에 없어 미확인

여섯 장면을 한 표로. 공통점은 「입원 여부를 고객이 정했다」는 것, 차이는 「기록이 있었는가」다

장면	고객의 생각	판정	불이익	당사에서 입원 없이 보장하는 길
백내장 다초점	입원 수술	통원(대법원 2025.1)	800만 → 20~30만원	130·131대질병수술비[백내장] · 안과질환수술비
하지정맥류 이틀 입원	양다리라 이틀	형식적 입원(대법원 2026.6)	입원의료비 0원	특정 비급여·신의료기술치료비 1종 · 수술비
자궁근종 하이푸	6시간 넘게 있었다	통원(서울중앙지법)	입원비 0 · 통원 7.5만원	특정질환3대치료비(하이푸·맘모톰·고주파)
한방병원 줄기세포 주사	다들 입원한다	9명 중 7명 기각	0원	입원일당 정의에서 한방병원 제외를 먼저 설명
숙박형 요양병원	치료받으며 지냈다	허위 장기입원 유형	환수 + 수사	181일이상 입원일당 · 간병인지원일당(요양병원 여부 확인)
합병증 도뇨관	집에 못 갔다	입원 인정(2026.5)	소송 뒤 402만원	기록이 남는 입원이면 입원일당도 산다

입원은 「결과」이지 「선택」이 아니다. 선택할 수 있는 것은 입원 없이도 나오는 특약을 미리 갖추는 일이다

출처: 2부 각 장 하단 표기와 같음. 「당사에서 입원 없이 보장하는 길」은 당사 특약 약관 명칭(proposal_smart/db.json)이며, 지급 조건·가입 가능 여부는 상품·플랜별 약관으로 확인한다

PART 03

네 가지 배경

의료기술 · 건보 재정 · 실손 손해율 · 제도. 네 힘이 모두 「입원은 줄이고, 심사는 늘리는」 쪽을 향한다

01 입원적정성이란

02 고객이 손해 보는 사례

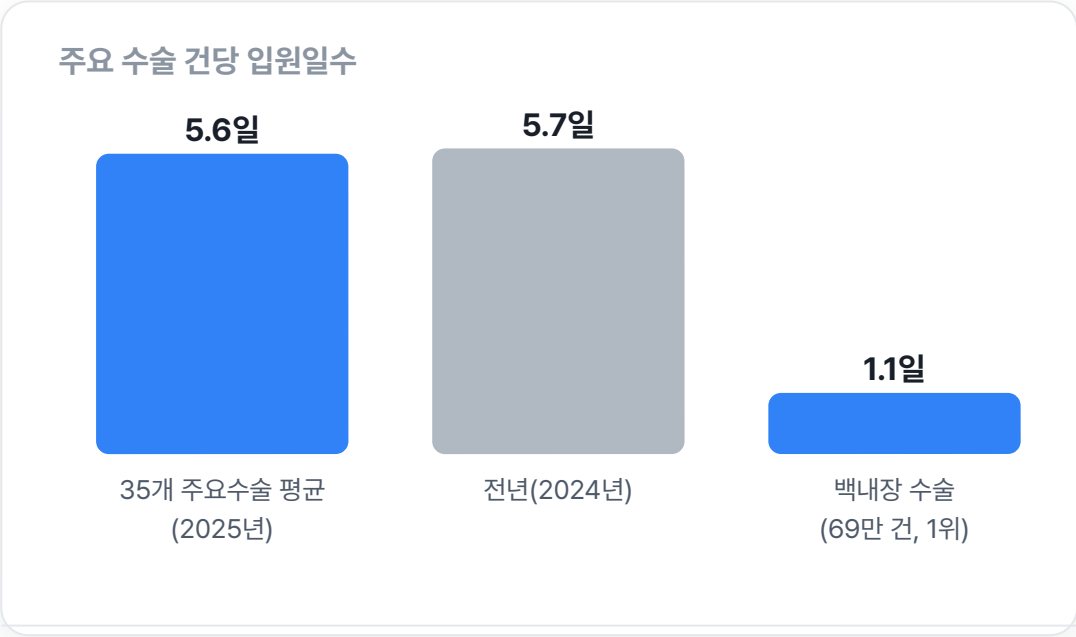
03 네 가지 배경

04 실손 재매입과 5세대

05 당사 특약 점검

06 현장 실천

치료는 빨라졌다. 주요수술 평균 입원 5.6일, 백내장은 1.1일, 로봇수술은 10년 새 8배. 「입원할 일」 자체가 줄어든다



로봇수술 연 8만 5천 건

2015년 약 1만 건의 8배. 누적 50만 건 육박. 복강경보다 개복 전환이 54% 적고 입원이 짧다

항암치료의 외래화

질병관리청: 입원하지 않고 외래에서 투여하는 항암제 치료가 늘고 있다. 표적항암제 원외처방 5,321억(2024, +20.4%)

백내장, OECD 평균 95%가 당일수술

우리나라만의 일이 아니다. 당일 퇴원이 세계 표준이 된 수술에 「입원」을 붙이면 심사 대상이 된다

입원 일수에 매달린 보장은 의학이 발전할수록 저절로 얇아진다. 보장 단위를 「치료 행위」로 옮길 첫째 이유

출처: 국민건강보험공단 「2025년 주요수술 통계연보」(헬스포커스·병원신문 2026 보도) · 머니투데이 2026.6.30 · 연합뉴스 2026.9.17 · 질병관리청 국가건강정보포털 · OECD Health at a Glance 2025. 하이푸·맘모톰 등 개별 시술의 통원화 비율은 공식 통계가 없어 정성적 추세로만 말한다

건강보험은 2026년 처음 적자로 돌아선다. 병상은 OECD 평균의 3배, 재원일수는 2위. 「입원 억제」가 국가 재정 과제가 됐다

−2.8조원

2026년 건보 당기수지 연말 추계(−2조 8,374억). 2025년은 +4,996억, 5년 연속 흑자였다

30.2조원

누적 준비금 30조 2,217억(2025년 말). 국회예산정책처는 현행 유지 시 2030년 소진을 경고

12.5 / 4.2개

인구 1천 명당 병상, 한국 vs OECD 평균(2024년 기준, 1위)

17.9일

입원환자 1인당 평균 재원일수, OECD 2위. 급성기 7.3일

44.9%

건보 진료비 116조 중 65세 이상 몫(2024). 노인 1인당 연 551만원, 전체 평균의 2.4배

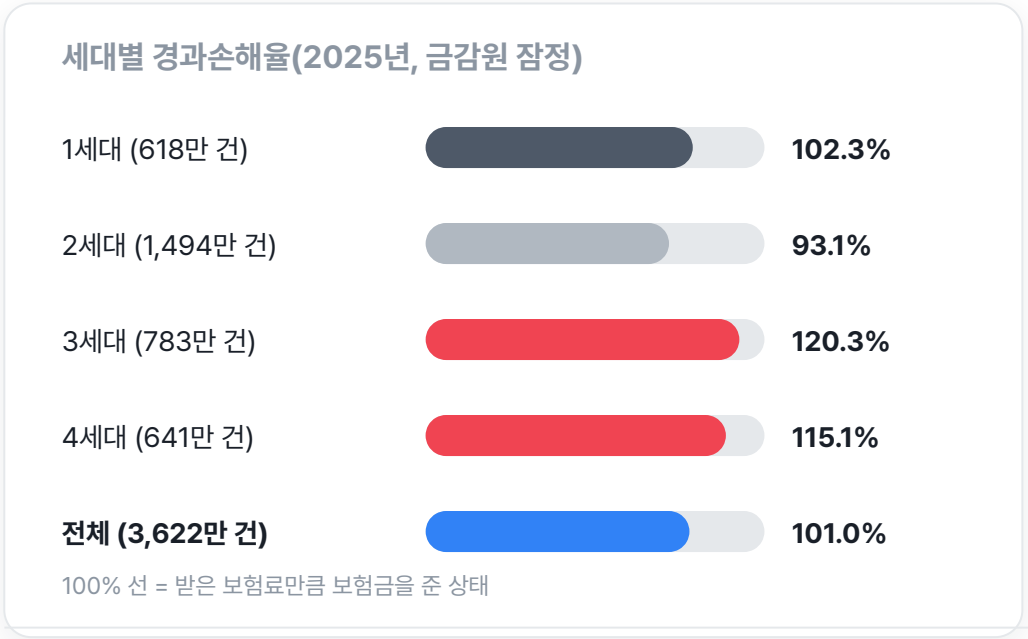
재정이 입원을 바라보는 방식

2026 보험료율 7.19% → 2027 동결(국고 +1.1조) → 2026.12 수가 개편 3.6조 → 장기입원 체감제 확대 논의

국가가 입원을 아끼기 시작하면 병원도 입원 기준을 조인다. 고객의 입원은 점점 「관찰 후 귀가」와 「통원」이 된다

출처: 한국경제·파이낸셜뉴스 2026.10.13(건보공단 중장기 재무관리계획) · 뉴스핌 2026.1.28(2025년 결산) · 경향신문 2025.8.18(국회예산정책처) · 보건복지부 「OECD 보건통계 2026」 분석(아시아경제 2026.7.23) · 건정심 2025.8.28, 2026.9.8 · 뉴스핌 2025.11.28(고령화 진료비). 체감제 확대는 보도 단계의 논의이며 확정 수치는 아니다

실손은 2025년 손해율 101%, 적자 1조 8,700억. 보험금의 57%가 비급여다. 보험사는 「입원이 맞았나」를 더 자주, 더 깊이 본다



비급여 보험금 9조 6,884억

전체 지급보험금 17조의 57.1%. 근골격계 2조 6,900억이 암·뇌·심 2조 5,500억보다 크다

비급여 상위: 도수치료 1조 3,858억

비급여 주사제 6,525억 · 체외충격파 5,110억 · 척추 수술 2,768억 · 증식치료 2,583억(2024년 말, 보험연구원)

의료자문 뒤 부지급 10.5%

상반기 손보 청구 4,581만 건 중 의료자문 22,435건, 그중 2,347건 부지급. 거절 평균 1,618만원

보험사기 적발 1조 1,571억(2025)

2026년 상반기 6,200억(+9.1%)으로 역대 상반기 최대. 장기보험이 39.8%

손해율이 100%를 넘으면 보험사는 지급을 줄일 수 있는 곳부터 본다. 「입원의 적정성」은 그중 가장 큰 칸이다

출처: 금융감독원 「2025년 실손의료보험 사업실적(잠정)」 2026.6.3(파이낸셜뉴스·국민일보·이투데이 보도) · 보험연구원(머니투데이 2025.12.11) · 경향신문 2026.6.7(의료자문) · 금감원 보험사기 적발 실적(뉴스핌 2026.9.28). 의료자문 통계는 상반기 16개 손보사 기준

제도는 2024년부터 한 방향으로 움직였다. 보험사기법 개정, 비급여·실손 개혁, 5세대 출시, 도수치료 관리급여, 전환 할인

2024. 8. 14

보험사기방지특별법 개정 시행

알선·유인·광고 금지(10년 이하 징역). 금융당국 조사권 강화. 심평원 입원적정성 심사 기준 마련 근거

2025. 1. 9

비급여 관리·실손 개혁방안 발표

실손을 중증 중심으로 재편. 재가입 조항 없는 1·2세대 1,582만 건(44%) 재매입 검토

2026. 5. 6

5세대 실손 출시(16개사)

비중증 비급여 자기부담 50%·연 1천만원, 도수·체외충격파·비급여 주사 제외. 중증은 입원 자기부담 상한 500만원

2026. 7. 1

도수치료 관리급여 시행

회당 43,850원 단일 수가, 본인부담 95%, 주 2회·연 15회

2026. 11

1·2세대 → 5세대 전환 할인

5세대 보험료 3년간 50% 할인, 6개월 한시. 현금 재매입 대신 택한 방식

외울 날짜는 셋이다. 2024.8 심사 근거, 2026.5 5세대, 2026.11 전환 할인. 고객의 질문이 여기서 나온다

출처: 뉴시스 2024.8.13 · 정책브리핑(법 개정) · 금융위원회 보도자료 2025.1.9 · 금융위원회 보도자료 2026.5(5세대) · 보건복지부 보도자료 2026.6(관리급여) · 머니투데이 2026.5.5(전환 할인). 전환 할인의 11월 시행 세부 약관은 금융위 11월 발표로 확인 필요

네 힘이 한 방향

입원은 줄이고,
입원 심사는 늘린다

의료기술은 입원할 일을 줄이고, 건보 재정은 입원을 억제하고, 실손 손해율은 심사를 늘리고, 제도는 비급여를 관리한다. 어느 하나도 「입원일당」 편이 아니다

의료기술
입원 5.6일 → 더 짧게

건보 재정
2026년 −2.8조

실손
손해율 101%

제도
5세대 · 전환 할인

PART 04

실손 재매입과 5세대

「보상금 받고 해지」는 「5세대로 갈아타면 3년 반값」이 됐다. 실손이 얇아질수록 정액 특약의 자리가 넓어진다

01 입원적정성이란

02 고객이 손해 보는 사례

03 네 가지 배경

04 실손 재매입과 5세대

05 당사 특약 점검

06 현장 실천

실손 다섯 세대, 한 표로 본다. 세대가 올라갈수록 자기부담은 커지고 비급여 한도는 줄어든다. 「입원」의 값도 함께 줄었다

구분	1세대	2세대	3세대	4세대	5세대
가입 시기	2009.9 이전	2009.10 ~ 2017.3	2017.4 ~ 2021.6	2021.7 ~ 2026.5	2026.5.6 ~
보유 계약(2025년 말)	618만 건 (17.1%)	1,494만 건 (41.2%)	783만 건 (21.6%)	641만 건 (17.7%)	출시 첫 달 신규 4.3만 건
경과손해율(2025년)	102.3%	93.1%	120.3%	115.1%	-
2026년 보험료 인상	3%대	5%대	16%대	20%대	4세대 대비 약 30% 저렴
비중증 비급여 자기부담	없음 또는 낮음	10~20%	특약 30%	특약 30%	50% · 연 1,000만원 · 도수·주사 제외
재가입(약관 변경) 조항	없음(2013.3 이전)	없음(2013.3 이전)	15년	5년	5년
이번 전환 할인 대상	대상	대상(2013.3 이전 계약)	-	-	전환 받는 쪽

증권의 「가입 연월」 하나만 읽어도 세대가 보이고, 세대가 보이면 전환 할인 대상인지가 보인다

출처: 금융감독원 「2025년 실손의료보험 사업실적(잠정)」 2026.6.3 · 헤럴드경제 2025.12.30(인상률) · 금융위원회 보도자료 2026.5(5세대) · 머니투데이 2026.5.5(전환 할인 대상). 1·2세대 자기부담률은 상품·시기별로 달라 대표값이며, 5세대 통원 한도 「하루 20만원」은 입법예고 기준으로 최종 약관 확인 권장

5세대는 「중증은 두껍게, 비중증은 얇게」. 비중증 비급여는 절반을 내 돈으로 내고, 도수·체외충격파·비급여 주사는 아예 빠진다

급여

입원 자기부담 20%

입원 자기부담 20% 유지. 통원은 건보 본인부담률에 연동(의원 30% · 병원 40% · 종합 50% · 상급종합 60%). 임신·출산·발달장애 급여 신규 보장

중증 비급여 (특약 1)

상한 500만원

연 5,000만원 한도, 자기부담 30% 유지. 상급종합·종합병원 입원 시 연간 자기부담 상한 500만원 신설. 통원은 30%와 3만원 중 큰 금액

비중증 비급여 (특약 2)

자기부담 50%

연 한도 5,000만 → 1,000만원, 자기부담 30 → 50%. 입원 회당 300만원, 통원 하루 20만원(50%와 5만원 중 큰 금액). 도수치료·체외충격파·비급여 주사제 제외

전환 실적은 아직 미미하다. 1·2세대에서 5세대로 자발적 전환은 9월 말 33,577건, 보유 1,643만 건의 약 0.2%(뉴스핌 2026.9.2 · 아주경제 2026.10.15). 그래서 11월 「3년 반값」 카드가 나왔다

5세대 가입자에게 도수·주사·비급여 통원은 실손이 거의 못 막는다. 그 자리를 채우는 것이 정액 치료비·수술비다

출처: 금융위원회 보도자료 2026.5 · 블로터 2026.5 · 뉴스1 2026.1.15 · 머니투데이 2026.5.5 · 보건복지부 2026.6(도수치료 관리급여 2026.7.1 시행). 세부 자기부담 수치는 최종 약관에서 확인한다

「재매입」은 현금 보상에서 「전환 할인」으로 바뀌었다. 2026년 11월부터 6개월, 1·2세대가 5세대로 가면 보험료를 3년간 절반만 낸다

- **2025. 1** — 계약 재매입 검토 발표. 1,582만 건(44%) 대상
- **2025. 12** — 「보험료 − 받은 보험금」 차액 보상안 업계 제시
- **2026. 1** — 시행령 개정안에서 재매입 조항 제외. 보험사 「조 단위 비용」 반발
- **2026. 5. 5** — 전환 할인으로 확정: 5세대 보험료 3년 50%, 11월 시행 · 6개월 한시
- **2026. 9** — 주계약 유지한 채 실손 「특약」으로 전환 허용. GA 부당 승환 관리 강화

금융당국 시뮬레이션 예시 · 1세대 60대 여성

월 178,489원 → 월 21,270원

5세대 전환 + 3년 50% 할인 적용. 3년 누적 약 559만원 절약 사례(파이낸셜뉴스 2026.5.6 · 헤럴드경제 2026.9). 단, 보장도 5세대 구조로 바뀐다

대상

2013. 3 이전 가입, 재가입 조항 없는 1·2세대

기간

2026. 11 시행, 6개월 한시 운영 뒤 연장 검토

철회

할인 신청 뒤 6개월 안에 청약철회 가능

다른 길

유지 + 선택형 할인 특약(비급여 일부 제외 시 30~40% 인하 예상)

고객의 질문은 「갈아타야 하나요」다. 답은 보험료가 아니라 「지난 3년 무엇으로 얼마를 받았나」에서 나온다

출처: 금융위원회 보도자료 2025.1.9 · 한국경제 2025.12.8 · 뉴스핌 2026.1.16 · 머니투데이 2026.4.3, 2026.5.5, 2026.9.11 · 시사오늘 2026.5 · 파이낸셜뉴스 2026.5.6. 「현금 재매입 폐기」는 공식 문구가 아니라 보도 흐름에서 읽은 추정이며, 11월 시행 세부(약관·참여 보험사)는 금융위 발표로 확인한다

전환 상담은 세 갈래다. 지난 3년 청구 이력으로 갈래를 나누고, 어느 갈래든 「실손이 비운 자리」를 정액 특약으로 채운다

A 유지

지난 3년 비급여 통원·도수·주사 청구가 잦은 고객

1·2세대 보장(낮은 자기부담)이 아직 유리. 다만 보험료 인상(1세대 3%대, 2세대 5%대)과 손해율 102%는 계속 오른다는 뜻

B 전환 + 할인

청구가 거의 없고 보험료 부담이 큰 60대 이상

3년 50% 할인의 효과가 가장 크다. 대신 비중증 비급여 자기부담 50%, 도수·주사 제외를 반드시 설명하고 6개월 철회권을 알린다

C 유지 + 선택형 할인

보장은 지키고 싶지만 보험료를 줄이고 싶은 고객

비급여 일부 제외·자기부담 상향으로 30~40% 인하 예상. 제외한 항목은 정액 특약으로 메운다

어느 갈래든 공통 — 실손이 비운 자리 → 도수·주사 → 치료비 정액 → 입원 축소 → 수술비·통원일당 → 비급여 신의료기술 → 특정치료비

전환 할인은 보험료 상담이 아니라 보장 재설계의 입구다. 5부의 특약 지도가 그 다음 장이다

주: 세 갈래의 기준은 교육용 상담 틀(가정값)이며 금융당국 지침이 아니다. 전환 권유 시 부당 승환(금융위 2026.9 감독규정 개정 예고)에 해당하지 않도록 비교 안내 서류를 남긴다

PART 05

당사 특약 점검

지급 조건이 「입원」인 특약과 「치료 행위」인 특약으로 갈라 본다. 앞은 설명 의무가 커지고, 뒤는 가치가 오른다

01 입원적정성이란

02 고객이 손해 보는 사례

03 네 가지 배경

04 실손 재매입과 5세대

05 **당사 특약 점검**

06 현장 실천

특약 지도. 왼쪽으로 갈수록 「입원」이 지급 조건이고, 오른쪽으로 갈수록 「치료 행위」가 조건이다. 트렌드는 오른쪽으로 흐른다

입원이 조건 (입원적정성 논란에 노출) | 입원 + 다른 조건 | 치료 행위가 조건 (입원 여부와 무관)

입원일당 계열

질병입원일당(1일이상) · 일반상해입원일당(1일이상) · 질병입원일당(181일이상)(요양,정신, 한방병원제외) · 상급종합병원 질병입원일당 · 종합병원 질병입원일당 · 질병중환자실입원일당

입원 + 병실·간병 조건

상급병실(1인실) 상급종합병원 질병입원일당(10일한도) · 2-3인실 종합병원 질병입원일당(30일한도) · 간병인사용 질병입원일당(plus) · 간호·간병통합서비스 사용 질병입원일당

입원 + 직접치료 조건

암직접치료입원일당(II)(요양병원제외) · 종합병원암직접치료입원일당(365일한도) · 암요양병원입원일당(II)(90일한도) · 뇌출혈입원일당(4일이상) · 급성심근경색증입원일당(4일이상)

통원 · 낮병동 · 응급실

뇌혈관질환통원일당(연간30회한) · 허혈성심장질환통원일당 · 암직접치료통원일당(상급종합병원) · 종합병원암직접치료낮병동입원일당(연간20일) · 응급실내원비(응급) · 일반상해입원후통원비

수술 · 치료 · 검사

수술비II(1-5종) · 수술비(1-7종, 연간3회한) · 1-5종수술비(plus) · 표적항암약물허가치료비(약물 개수별) · 항암방사선약물치료비 · 암·2대질환 주요치료비(연간1회, 10년) · 특정 비급여·신의료기술치료비(1-4종) · 특정질환3대치료비 · 통합치료비 · MRI·CT·PET 검사비 · 통합생활지원비

주: 특약 명칭은 당사 약관 명칭(proposal_smart/db.json, 1,765개 중 발췌). 「입원 + 직접치료」 칸은 입원 요건에 암 직접치료 요건이 더해져 심사 쟁점이 둘이다. 가입 가능 여부와 세부 지급 조건은 상품·플랜별 약관으로 확인한다

입원일당은 나쁜 특약이 아니다. 다만 「입원」 한 단어에 세 가지 조건이 숨어 있어, 팔 때 세 줄을 읽어 주지 않으면 민원이 된다

조건 1 · 병원 종류

요양병원 · 정신병원 · 한방병원 제외

「질병입원일당(181일이상)(요양,정신,한방병원제외)」처럼 이름에 쓰인 것도 있고, 「질병입원일당(1일이상)」처럼 약관 정의 안에만 있는 것도 있다. 사례 4·5가 여기서 걸린다

조건 2 · 입원의 실질

6시간 · 관찰 기록 · 개별 필요성

백내장·하이푸·정맥류 판결의 기준이 그대로 적용된다. 입원일당은 실손보다 금액이 작아 다툼이 적을 뿐, 요건은 같다

조건 3 · 기간과 한도

1일이상 / 4일이상 / 30일 · 180일 · 365일 한도

뇌출혈·급성심근경색증입원일당은 4일이상, 상급병실 1인실은 10일한도, 중환자실은 별도. 재원일수 5.6일 시대에 「4일이상」은 실제로 못 받는 경우가 생긴다

그래도 입원일당이 사는 자리: 뇌졸중·심근경색·암 수술처럼 기록이 남는 「진짜 입원」, 중환자실, 181일 이상 장기 입원. 즉 입원일당은 「가벼운 입원」이 아니라 「무거운 입원」용으로 설명한다

「며칠 누우면 얼마」가 아니라 「이런 병원에서, 이런 치료로, 이 기간 이상 입원하면」으로 세 조건을 먼저 말한다

출처: 당사 특약 약관 정의(tool_body.js) · 특약 명칭(db.json) · 2부 판례. 재원일수 5.6일은 건보공단 2025년 주요수술 통계연보

조건이 둘이면 쟁점도 둘이다. 간병인 「사용」 영수증, 1인실 「배정」, 암 「직접치료」가 입원 요건 위에 얹힌다

특약(약관 명칭)	입원 요건 위에 얹힌 조건	현장에서 생기는 오해	설명할 때 한 줄
간병인사용 질병입원일당(plus)(1일이상 180일한도)(요양병원제외)	유상 간병인 사용 사실 + 사업자 등록 확인(약관 「간병인」 정의)	가족 간병, 미등록 간병인은 대상이 아니다. 요양병원 입원은 별도 특약	「간병인을 직접 구해 쓴 날, 영수증이 있는 날」
갱신형 간병인지원 질병입원일당(VII)(1일이상 180일한도)	회사가 간병인을 보내 주는 서비스형(지원). 입원 자체는 요건	사용형과 지원형을 섞어 설명하면 「왜 돈이 안 나오나」가 된다	「불러 드리는 간병인」 vs 「직접 쓰고 받는 일당」
상급병실(1인실) 상급종합병원 질병입원일당(1일이상 10일한도)	1인실 배정 + 상급종합병원 + 10일 한도	다인실 대기 중 하루 1인실, 2-3인실은 다른 특약	「상급종합 1인실에 실제로 든 날, 열흘까지」
암직접치료입원일당(II)(요양병원제외, 1일이상)	암의 「직접치료」 목적 입원. 합병증·후유증·요양 목적은 제외	항암 뒤 체력 회복 입원, 요양병원 입원이 가장 많이 다툰다	「암을 없애는 치료를 위한 입원」, 요양은 암요양병원입원일당(90일한도)으로
종합병원 전신마취치료비(급여, 6시간이상)	전신마취 6시간 이상(4시간 이상 특약도 있음)	마취 시간은 수술 기록에 남는다. 입원 여부와는 별개	「긴 수술을 받으면」, 입원일수는 묻지 않는다

둘째 조건이 있는 특약은 「입원 + ○○」로 끊어 읽어 준다. ○○가 고객의 기억에 남아야 청구할 때 서류가 준비된다

출처: 당사 약관 「입원」·「간병인」 정의(tool_body.js) · 특약 명칭(db.json). 「암직접치료」의 세부 범위(합병증·후유증·요양 제외)는 해당 특약 약관 조문으로 확인한다

입원이 통원이 되는 시대의 첫 수혜자. 통원일당·낮병동입원일당·응급실내원비는 「입원 아님」 판정이 나도 그 자리에서 지급 사유가 된다

뇌혈관질환통원일당(연간30회한)

허혈성심장질환통원일당(연간30회한) · 상급종합병원형 · 종합병원형

뇌·심장은 급성기 입원이 짧아지고 외래 추적이 길어진다. 연 30회면 한 달 2~3회 외래를 1년 내내 받는다

탑재: 케어프리 · 통합간편

암직접치료통원일당(상급종합병원)

감액 및 면책기간 미적용형 있음

항암은 외래 투여가 늘고 표적항암제는 처방 환자의 약 40%(아이큐비아). 입원 없는 항암의 날수를 세어 준다

탑재: 또또암 · 또또암간편 · 케어프리 · 통합간편

종합병원암직접치료낮병동입원일당(급여, 1일1회한, 연간20일한도)

낮병동(6시간 이상 관찰·치료 후 귀가)을 「입원」으로 명시

백내장·하이푸처럼 「입원 아님」이 되는 하루를 특약 이름부터 낮병동으로 받아 준다

탑재: 또또암 · 또또암간편

응급실내원비(응급) · 응급실내원비(1-3등급)

의료기관 및 민간 구급차 이용형 있음

응급실에서 처치·관찰 뒤 귀가한 하루는 입원이 아니다. 내원 자체를 보장한다

탑재: 케어프리 · 운전자

통원 판정이 나도 그 자리에서 지급 사유가 되는 네 특약. 입원일당과 짝으로 설계하면 「입원 아님」의 날이 비지 않는다

출처: 당사 특약 명칭·탑재 상품(db.json) · 당사 약관 「낮병동 입원(급여)」 정의 · 질병관리청 국가건강정보포털(항암 외래화) · 아이큐비아(네이트 2026.3.23). 탑재 상품 표기는 db.json 기준이며 판매 중 플랜은 상품 안내로 확인

약관의 「수술」 정의에는 입원이 없다. 수술비·치료비·검사비는 「무엇을 받았나」만 묻는다. 5세대 실손이 비운 비급여 자리를 메우는 것도 이쪽이다

수술비 계열

수술비II(1-5종) · 수술비(1-7종, 연간3회한) · 질병 1-5종수술비(plus)(연간2회이상) · 130·131대질병수술비 · 폴립및양성종양수술비(1-6종)

「수술」 = 의사가 필요 인정 + 기구로 절단·절제 등의 조작. 신의료기술 수술 포함. 당일수술이 늘수록 쓰임이 는다

항암 치료비

표적항암약물허가치료비(연간 약물종류 개수별) · 항암방사선약물치료비 · 특정면역항암약물허가치료비 · 비급여 항암약물치료비(연간1회한, 10년간)

외래 항암의 시대. 약물 종류 개수별로 매년 반복 지급되는 구조는 입원일수와 무관하다

주요치료비 · 통합치료비

암 주요치료비(연간1회한, 10년간) · 2대질환 주요치료비 · 암 통합치료비(기본형) · 질병·상해 통합치료비 · 특정순환계질환 통합치료비

검사(MRI·CT·PET) · 수술(1-5종) · 주요치료(시술·CRRT·전신마취 6시간 등) 항목별 지급. 약관 예시에 「외래 1회 + 입원 1회」가 따로 세어진다

비급여 · 신의료기술 치료비

질병 특정 비급여,신의료기술치료비(1-4종): 1종 근골 및 하지정맥류 · 2종 기타질환 · 3종 로봇보조 · 4종 여성 비뇨생식기 · 특정질환3대치료비(하이푸·맘모톰·갑상선 고주파)

2부의 정맥류·하이푸·맘모톰이 모두 여기 있다. 5세대 실손이 비중증 비급여를 50% 자기부담으로 만든 자리

검사비 · 생활지원

암 MRI촬영검사비 · 암 CT촬영검사비 · PET검사비 · 3대질환 MRI촬영검사비 · 암 통합생활지원비(월간한도) · 2대질환 통합생활지원비

진단 전 검사와 치료 뒤 생활비. 입원 전후의 「입원 아닌 날」을 채운다

로봇 · 특수 수술

다빈치로봇 암수술비 · 뇌정위적방사선수술비(급여) · 기계적혈전제거술(카테터법)치료비II · 항암양성자·중입자방사선치료비

로봇수술 연 8.5만 건(2015년의 8배). 입원은 짧아지고 치료 단가는 올라가는 영역

출처: 당사 약관 「수술」·「통합치료」 정의와 예시(tool_body.js) · 특약 명칭(db.json) · 머니투데이 2026.6.30(로봇수술) · 금융위 2026.5(5세대). 지급 금액·횟수·면책은 특약별 약관 지급표를 따른다

트렌드 적합도로 매긴 잠재력 순위. 네 배경(의료기술·건보·실손·제도) 각각에 얼마나 올라타는지를 별로 셌다

순위	특약(약관 명칭)	입원 의존	통원화 수혜	비급여 관리 수혜	적합도	한 줄 판매 포인트
1	표적항암약물허가치료비(연간 약물종류 개수별)	없음	높음	높음	★★★★	외래 항암 · 약물 개수별 매년 반복. 입원일수와 무관
2	질병 특정 비급여,신의료기술치료비(1-4종) · 특정질환3대치료비	없음	높음	매우 높음	★★★★	정맥류·하이푸·맘모톰·로봇. 5세대가 비운 자리
3	수술비II(1-5종) · 수술비(1-7종) · 1-5종수술비(plus)	없음	높음	중간	★★★★	당일수술이 늘수록 청구가 는다. 백내장도 수술
4	암·질병·상해 통합치료비 · 주요치료비(연간1회, 10년)	낮음(항목별)	높음	높음	★★★☆	검사·수술·시술을 항목별로. 외래 1회 + 입원 1회 따로 센다
5	뇌혈관·허혈성심장질환 통원일당 · 암직접치료통원일당	없음	매우 높음	낮음	★★★☆	입원이 짧아진 만큼 길어진 외래를 날수로
6	종합병원암직접치료낮병동입원일당 · 응급실내원비	없음	높음	낮음	★★★☆	「입원 아님」이 되는 하루를 이름부터 받아 준다
7	간병인지원 입원일당(서비스형) · 통합생활지원비	있음 / 없음	중간	중간	★★☆☆	입원하면 사람을 보내고, 치료 뒤 생활비를 준다
8	입원일당(1일이상) · 상급병실 · 중환자실 입원일당	높음	낮음	낮음	★☆☆☆	「무거운 입원」 전용으로 세 조건과 함께 판다

위 세 줄(표적항암 · 비급여 신의료기술 치료비 · 수술비)이 입원적정성 시대의 앞자리다. 입원일당은 뒤에서 받친다. 별점은 이 교안의 평가(가정값)이며 회사 공식 등급이 아니다. 「입원 의존」은 약관 지급 조건에 입원이 있는지, 「통원화 수혜」는 입원 감소 추세에서 청구 가능성이 느는지, 「비급여 관리 수혜」는 5세대 실손·관리급여로 실손 보장이 줄어 정액 보장의 필요가 커지는지를 뜻한다

PART 06

현장 실천

상담 화법 세 문장, 입원 전 안내 다섯 가지, 그리고 정리

01 입원적정성이란

02 고객이 손해 보는 사례

03 네 가지 배경

04 실손 재매입과 5세대

05 당사 특약 점검

06 **현장 실천**

세 문장이면 된다. 「입원이 줄어든다」로 열고, 「입원은 고객이 정하지 못한다」로 이어, 「치료 행위를 보장받자」로 닫는다

혹시 백내장이나 정맥류 수술 받으신 분 주변에 계세요? 요즘은 수술하고 그날 집에 가는 게 보통이에요. 주요수술 평균 입원이 5.6일, 백내장은 1.1일이에요.

그래도 입원하면 입원비는 나오는 거 아니에요?

입원했는지는 병원 침대가 아니라 약관이 정해요. 작년 대법원에서 백내장 입원 137명이 전부 통원으로 판정됐고, 올해는 정맥류 이틀 입원도 통원이 됐어요. 그래서 요즘 설계는 「며칠 입원했나」가 아니라 「무슨 치료를 받았나」로 해요.

그럼 뭘 봐야 해요?

수술비, 치료비, 통원일당이에요. 입원을 했든 안 했든 수술을 했으면 수술비, 항암을 받았으면 치료비, 외래를 다녔으면 통원일당. 고객님 증권에서 이 세 칸부터 같이 볼게요.

열기 입원이 줄어든다

주요수술 5.6일 · 백내장 1.1일 · 로봇수술 8배

잇기 입원은 고객이 정하지 못한다

대법원 2025.1 백내장 · 2026.6 정맥류 · 당사 9월 심사 강화

닫기 치료 행위를 보장받자

수술비 · 치료비 · 통원일당, 증권의 세 칸

주: 화법 속 수치는 3부·2부 출처와 같다(건보공단 2025 주요수술 통계연보 · 대법원 2024다305643 · 대법원 2026다202566 · 쿠키뉴스 2026.9.14). 고객 앞에서 「보험사기」라는 말은 쓰지 않는다

고객이 입원하기 전에 전화로 알려 줄 다섯 가지. 이 다섯이 지켜지면 통원 판정은 줄고, 판정을 받아도 다툴 근거가 남는다

1	**병원 종류를 먼저 묻는다**	요양병원 · 정신병원 · 한방병원이면 입원일당 특약 정의에서 빠질 수 있다. 상급종합·종합병원이면 전용 일당이 있다
2	**「왜 입원이 필요한지」를 의사에게 묻게 한다**	합병증 위험, 마취 종류, 당일 귀가가 어려운 이유. 이 대답이 진료기록에 남아야 한다(사례 6의 402만원)
3	**입원 중 외출·외박을 하지 않는다**	「의사의 관리 하에 치료에 전념」이 약관 요건이다. 외출 기록은 실질적 입원을 부정하는 근거가 된다
4	**양쪽·두 부위를 나눠 입원하지 않는다**	하지정맥류 대법원 판결의 핵심. 같은 날 통원으로 가능한 치료를 이틀로 나누면 형식적 입원이 된다
5	**입원이 아니어도 나오는 특약을 같이 청구한다**	수술비 · 치료비 · 통원일당 · 낮병동입원일당 · 응급실내원비. 통원 판정이 나도 이 특약들은 그대로 산다

다섯 가지의 공통점은 「기록」이다. 입원이 맞다면 기록이 지켜 주고, 입원이 아니라면 기록이 미리 말해 준다

출처: 당사 약관 「입원」 정의 · 대법원 2026다202566 · 연합 2026.5.12(402만원 판결) · 데일리메디 2026(한방병원). 안내 문구는 교안의 제안이며 보상 안내 공식 문서가 아니다

네 문장을 들고 나간다

1

입원은 줄고 심사는 는다

의료기술 · 건보 재정 · 실손 손해율 · 제도, 네 힘이 한 방향이다

2

입원은 결과이지 선택이 아니다

백내장 · 정맥류 · 하이푸 · 줄기세포 주사, 고객이 정한 입원은 통원이 됐다

3

실손은 얇아지고, 정액은 넓어진다

5세대 비중증 50% 자기부담, 1·2세대 전환 할인. 비운 자리는 수술비·치료비가 채운다

4

「며칠 입원」이 아니라 「무슨 치료」

입원일당은 무거운 입원용으로 세 조건과 함께, 수술비·치료비·통원일당은 앞자리로

오늘 할 일 하나. 고객 증권 세 장을 꺼내 「입원일당」 칸과 「수술비·치료비·통원일당」 칸을 나란히 적어 본다

출처와 한계. 모든 수치는 아래 자료의 보도·발표값이며, 원문을 직접 열어 확인하지 못한 항목은 「원문 확인 권장」으로 둔다

판례·감독

서울고법 2021나2013354(2022.1.20, 대법원 2022.6.16 확정) · 대법원 2024다305643(2025.1.23) · 대법원 2026다202566(2026.6.11) · 대법원 2004도6557(2006.1.12) · 금감원 보도자료 2025.3.10, 2025.9.8 · 금감원 금융민원 동향 2026.4.21 · 금감원 제2차 금융소비자보호 토론회 2025.11.18 · 금감원 행정지도 2026.6.22

제도·정책

보험사기방지특별법 개정(2024.8.14 시행) · 심평원 공고 2024-193호 · 금융위 보도자료 2025.1.9, 2026.5(5세대), 2026.5.5(전환 할인), 2026.9.11 · 보건복지부 2026.6(도수치료 관리급여) · 건정심 2025.8.28, 2026.9.8, 2026.6.25

통계

금감원 2025년 실손 사업실적(잠정) 2026.6.3 · 보험연구원(비급여 상위 항목) · 건보공단 2025년 주요수술 통계연보 · 건보공단 중장기 재무관리계획(2026.10.13 보도) · 국회예산정책처 2025.8 · 보건복지부 OECD 보건통계 2026 분석 · OECD Health at a Glance 2025 · 금감원 보험사기 적발 실적

한계 · 추정 표기 항목

- 조사 방식: 검색 엔진이 돌려준 기사·보도자료 요약을 근거로 했고 원문 전문을 직접 연 항목은 없다. 교육 전 핵심 수치는 원문 URL을 한 번 연다
- 실손 표준약관 본문의 「6시간」 문구 유무는 미확인. 6시간은 복지부 고시(낮병동)와 판례에서 온 기준으로 설명했다
- 심평원 입원적정성 심사의 전국 「부적정 판정 비율」은 공개 통계가 없다
- 하이푸 1심 선고일, 402만원 판결의 수술명, 한방병원 판결 선고일은 보도에 없다
- 5세대 통원 「하루 20만원」, 전환 할인 11월 세부 약관은 최종 발표로 확인한다
- 5부 잠재력 별점과 4부 상담 세 갈래는 이 교안의 가정값이다

당사 자료: 특약 약관 원문(tool_body.js) · 특약 마스터(proposal_smart/db.json, 1,765개) · 디자인은 첨부 「55 PLAN 부산센터 교육」 HTML의 토큰(Pretendard · #3182F6 · #191F28 · 24px 카드)을 따랐다